盐酸多巴酚丁胺注射液说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

【说明书修订日期】

核准日期：2024年9月03日
修改日期：2024年9月23日
修改日期：2024年11月01日

【药品名称】

盐酸多巴酚丁胺注射液

【英文名称】

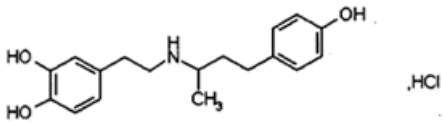
Dobutamine Hydrochloride Injection

【汉语拼音】

Yansuan Duobafending'an Zhusheye

【成份】

本品活性成份为盐酸多巴酚丁胺。
化学名称：4-[2-[[1-甲基-3-(4-羟苯基)丙基]氨基]乙基]-1,2-苯二酚盐酸盐
化学结构式：



分子式：$C_{18}H_{23}NO_3 \cdot HCl$
分子量：337.85
辅料：甘露醇、亚硫酸氢钠、盐酸、注射用水。

【性状】

本品为无色的澄明液体。

【适应症】

用于器质性心脏病时心肌收缩力下降引起的心力衰竭，包括心脏直视手术后所致的低排血量综合征，作为短期支持治疗。

【规格】

5ml:100mg(按$C_{18}H_{23}NO_3$计)

【用法用量】

成人常用量将多巴酚丁胺加于5%葡萄糖液或0.9%氯化钠注射液中稀释后，以滴速每分钟2.5-10μg/kg给予，在每分钟15μg/kg以下的剂量时，心率和外周血管阻力基本无变化；偶用每分钟＞15μg/kg，但需注意过大剂量仍然有可能加速心率并产生心律失常。

【不良反应】

不良反应信息来源于文献。
可有心悸、恶心、头痛、胸痛、气短等。如出现收缩压增加[多数增高1.33～2.67Kpa(10～20mmHg)，少数升高

6.67Kpa(50mmHg)或更多]，心率增快(多数在原来基础上每分钟增加5-10次，少数可增加30次以上)者，与剂量有关，应减量或暂停用药。
评估的521例患者的安全性数据中，有30例(5.8%)具有不良反应，包括临床检查的异常变化。在重新检查结束后接受安全性评估的6506位患者中，有166位患者(2.55%)观察到了不良反应，包括临床检查的异常波动。
应激性心肌病(发生率未知*)：可能发生应激性心肌病，心室收缩期ST段抬高和室壁运动异常。如果观察到任何异常发现，例如心肌收缩功能较前下降，应立即停止使用该药物，并采取适当措施。
其他不良反应

类型\频率	5%或以上或频率未知*	0.1-5%
循环器官注1	心律不齐(心动过速，期外收缩等)，血压降低	血压过度升高，躁动不安，胸部不适，心绞痛，前胸温暖，呼吸急促
消化器官		恶心，腹痛等
注射部位		注射部位发红，肿胀等
其他	血清钾减少	头痛，皮疹，嗜酸性粒细胞增多

注1：如果出现症状，请采取适当的措施，例如减少剂量或停药。
*：由于国外自发报告或副作用，频率未知。

【禁忌】

(1)肥厚性梗阻性心肌病患者(特发性肥厚性主动脉瓣下狭窄)
(2)有盐酸多巴酚丁胺过敏史的患者
(3)严重快速性心律失常患者
(4)主动脉夹层等严重血管病变的患者
(5)嗜铬细胞瘤患者

【注意事项】

(1)交叉过敏反应，对其他拟交感药过敏，可能对本品也敏感。
(2)下列情况应慎用：
①心房颤动，多巴酚丁胺能加快房室传导，心室率加速，如须用本品，应先给予洋地黄类药；②高血压可能加重；③严重的机械梗阻，如重度主动脉瓣狭窄，多巴酚丁胺可能无效；④低血容量时应用本品可加重，故用前须先加以纠正；⑤室性心律失常可能加重；⑥心肌梗死后，使用大量本品可能使心肌耗氧量增加而加重缺血。⑦用药期间应定时或连续监测心电图、血压、心排血量，必要或可能时监测肺楔嵌压。⑧心室充盈受损(缩窄性心包炎、心包填塞等)的患者，症状可能恶化。
(3)其他注意事项
在急性循环不足时加强心脏收缩力：在使用本品之前，应采取必要的措施，例如纠正体液流失和呼吸管理。使用本品过程中，应监测患者的状况，例如血压，心率，心电图和尿液量以及肺动脉楔压和心率输出。
对于急性循环功能不全并伴有低血压的患者，应考虑采取其他适当的措施，例如给予外周血管收缩药。
如果在服用本药期间心率或收缩压过度升高，则可能发生过量，在这种情况下，应采取适当的措施，例如降低剂量。
给药72小时或更长时间后可能出现耐受性，可能有必要增加剂量。

【孕妇及哺乳期妇女用药】

尚未确定孕妇及哺乳期妇女用药的有效性和安全性。仅当治疗益处大于风险时，才对孕妇或可能怀孕的妇女给药。

【儿童用药】

本品在小儿应用缺乏研究。

【老年用药】

通常老年人的生理功能会降低，因此应谨慎进行给药，例如从低剂量开始给药。

【药物相互作用】

(1)与全麻药尤其环丙烷、氟烷等同用，室性心律失常发生的可能性增加。
(2)与β受体阻滞剂同用，可拮抗本品对β_1受体的作用，导致α受体作用占优势，外周血管的总阻力加大。
(3)与硝普钠同用，可导致心排血量微增，肺楔嵌压略降。
(4)本品不得与碳酸氢钠等碱性药物混合使用。

【药物过量】

症状：食欲不振，恶心，呕吐，躁动，呼吸急促，胸痛等。此外，可能发生心动过速心律不齐，心肌缺血，心室纤颤，血压升高、低血压等。
治疗：由于盐酸多巴酚丁胺的半衰期短，通常可以通过降低剂量或停药来恢复血压升高。如果没有恢复，请考虑服用短期α受体阻滞剂。对于严重的室性心动过速，应考虑服用盐酸普萘洛尔或利多卡因。

【临床药理】

药代动力学
口服无效，静脉注入1～2分钟内起效，如缓慢滴注可延长到10分钟，一般静注后10分钟作用达高峰，持续数分钟。表观分布容积为0.2L/kg，清除率为244L/h，半衰期约为2分钟，在肝脏代谢成无活性的化合物。代谢物主要经肾脏排出。

【药理毒理】

药理作用
盐酸多巴酚丁胺是一种直接作用的正性肌力药物，其主要活性来自于激动心脏β受体，同时产生相对较轻的变时、升高血压、致心律失常和舒张血管作用。与多巴胺比较，它并不促进去甲肾上腺素释放。动物研究表明，在获得强心作用时，盐酸多巴酚丁胺引发心率加快和外周血管阻力下降的作用均比异丙肾上腺素小。
毒理研究
遗传毒性：尚未开展。
生殖毒性：大鼠生殖毒性试验给药剂量达正常人体剂量(以10μg/kg/min给药24小时，每日总剂量14.4mg/kg)，兔生殖毒性试验给药剂量达两倍人体正常剂量，均未观察到盐酸多巴酚丁胺的胚胎毒性证据。
致癌性：尚未开展。

【贮藏】

遮光，密闭，不超过30℃保存。

【包装】

中硼硅玻璃安瓿。5支/盒。

【有效期】

24个月

【执行标准】

YBH24512024

【批准文号】

国药准字H20244807

【药品上市许可持有人】

名　称：南京泽恒医药技术开发有限公司
注册地址：南京市栖霞区仙林街道纬地路9号江苏生命科技园D6栋903、905、907室
邮政编码：210046
电　话：025-56663133

传　真：025-85557300

【生产企业】

企业名称：江苏神龙药业有限公司
生产地址：东台市纬八路15号
邮政编码：224200
电话：0515-85213628
传真：0515-85260163